Verificação do escopo — Macaparana Saúde

Revisão de 04/10/2026. O resultado é um sistema acadêmico funcional com dados fictícios. Implementação e teste local não equivalem à implantação municipal. As evidências anteriores permanecem como histórico; a revisão tem evidências adicionais em `revisao/`.

Requisito do enunciado	Resultado da revisão	Onde verificar
Pacientes SUS, acompanhantes e transporte sem TFD	Implementado; modalidades separadas	Pacientes, Solicitações
TFD, regulação, transporte, motorista, financeiro, faturamento e controle	Perfis implementados; faturamento adicionado nesta revisão	Login e permissões no servidor
Solicitação, análise, autorização e laudo	Implementado com bloqueio sem laudo e motivo da decisão	Solicitações
Calendário semanal e datas avulsas entre competências	Implementado com validade e proteção contra duplicidade	Calendário
Dados do paciente, acompanhante, endereço, embarque e banco	Implementado; um acompanhante cadastrado por paciente nesta versão	Pacientes
Unidade identificada por CNES e especialidade	Implementado; CNES informado manualmente, sem validação externa	Frota e referências / Solicitações
Reutilização de referências válidas	Cadastros ativos reutilizáveis e autorização dentro da validade	Solicitações / Calendário
Veículos, motoristas, capacidade e acessibilidade	Implementado; acompanhante ocupa lugar, conflitos e CNH verificados	Viagens
Rotas e alocação por data e trecho	Complementado: paradas ordenadas, intervalo de embarque/desembarque, capacidade em cada segmento	Rotas e trechos
Alterações rastreáveis	Auditoria de criação, retirada, nova alocação e alteração de rota justificada	Auditoria
Quilômetros reais, consumo e custos	Implementado no encerramento	Viagens / Indicadores e piloto
Mapas para apoio	Opcional no enunciado; não conectado. Rota e distância estimada são informadas pela equipe	Viagens
Confirmação antecipada e alternativa assistida	Implementado; canal e observação acrescentados. Resposta aparece na lista do motorista	Rotas e trechos / Viagens
WhatsApp quando viável e autorizado	Não integrado. É possível registrar uma resposta obtida externamente pela equipe; não há envio de mensagem	Confirmação assistida
Conferência mensal em tabela compacta de datas	Implementado com abertura da ocorrência e documentos	Conferência mensal

Requisito do enunciado	Resultado da revisão	Onde verificar
Declaração, viagem, permanência e prova separada do acompanhante	Implementado; permanência é texto obrigatório, documentos são independentes	Ocorrência / Conferência mensal
Folha, contabilidade, pagamento e pendências por etapa	Implementado; regras financeiras demonstrativas e estágios distintos	Ajudas de custo
Preparação da produção	Complementado: perfil de faturamento, procedimento informado, quantidade, destino de revisão, protocolo e CSV por competência	Produzir / faturar
Produção em sistemas oficiais	Depende de catálogo, elegibilidade, leiaute e homologação definidos com o município; CSV interno não deve ser importado como leiaute oficial	Documentação e aviso na tela
Painel assistencial, operacional, financeiro e documentos de origem	Implementado com vínculos entre paciente, solicitação, ocorrência, viagem, documentos e benefício	Visão geral / Indicadores / Detalhes
Indicadores de custo e desempenho	Complementado com custo por embarque em viagens encerradas, km/l, ausência e pendências, com denominadores explícitos	Indicadores e piloto
Proteção dos dados	Sessão, hash de senha, autorização no servidor, restrição do motorista, auditoria, consultas parametrizadas e backup local consistente	Testes / Manual de operação
Capacitação e suporte	Materiais e registros de oficina/chamado implementados; atendimento institucional precisa de equipe designada	Suporte / Manual
Demonstração em rotina municipal	Pendente de participação e autorização da prefeitura. Testes locais não são demonstração municipal	Plano de piloto
Medição de resultados do piloto	Ferramenta implementada com linha de base, resultado, período, fonte, responsável e distinção entre simulação e rotina municipal. Medição real pendente	Indicadores e piloto
e-SUS APS e integração CNES	Condicionadas a interfaces, credenciais e permissões; não conectadas	Limites de integração

Complementos desta revisão

O banco existente é migrado sem apagar seus registros. Viagens antigas continuam com um segmento integral. Nas viagens novas, a equipe pode definir paradas antes da alocação. A capacidade é calculada separadamente em cada intervalo; uma vaga pode ser reutilizada após o desembarque previsto. O embarque operacional continua registrado por ocorrência; não há rastreamento GPS nem comprovação automática de desembarque em cada parada.

O faturamento pode preparar somente ocorrências conciliadas. O código possui validação de formato, não de existência no catálogo oficial. CNS ausente, identificadores fictícios, elegibilidade e demais exigências do destinatário precisam ser revisados. Encaminhar registra protocolo interno e não transmite ao SUS. Registros encaminhados não são sobrescritos por nova preparação.

As métricas automáticas usam registros locais. Custo de transporte não inclui ajudas de custo; o custo por embarque usa pacientes embarcados nas mesmas viagens encerradas do numerador. A ocupação por trecho é reserva de lugares, incluindo acompanhante, e não medida de presença física do acompanhante. Não há economia, ganho percentual ou piloto municipal comprovado neste projeto.

O que depende de terceiros

Validação técnica da revisão: 27 testes automatizados aprovados, fluxo completo até pagamento aprovado no navegador e sete capturas adicionais das novas funcionalidades; sem erros JavaScript nos fluxos verificados. Os dados usados são fictícios. Consulte `resultado-testes.txt`, `teste-navegador.json` e `revisao/resultado.json`.

1. Município: validar fluxos, valores, critérios de benefício, responsabilidades e aceite funcional.
2. Sistemas oficiais: disponibilizar interfaces e autorizar credenciais; definir procedimento, elegibilidade e leiaute por destino.
3. Infraestrutura: contas individuais, HTTPS, armazenamento e backups protegidos, monitoramento e recuperação testada antes de dados reais.
4. Equipe municipal: realizar a capacitação, operar o piloto, produzir fontes de medição e assinar o relatório de resultados.

Essas etapas não podem ser declaradas concluídas por alterações no código ou dados simulados.